GOBIERNO DE LA REPÚBLICADE HONDURAS

SECRETARIA DE SALUD
REGIÓN SANITARIA
METROPOLITANA DEL DC

MALARIA SE#11

Situación Epidemiológica Región Sanitaria #19, Honduras SE11/ Año 2026: Hasta la Semana Epidemiológica **No. 11**– Año 2026, se reporta un caso de Plasmodium vivax, no se reporta casos para Plasmodium falciparum. En comparación a la **SE11** del 2025 que no se notificaron casos.

Hasta la fecha no hay defunciones por malaria.

Tasa de Morbilidad de Malaria RSMDC, SE11 Año 2025-2026

TASA DE LA REGION 2025	**0.22**
TASA DE LA REGION 2026	**0.072**
AUMENTO	**0%**
DISMINUCION	**66%**

Por 100mil habitantes
Pob 2026 = 1.372.705 habitantes
Fuente: Fichas de notificación malaria UVS-RSM 2025-2026

Distribución porcentual de la infección por Malaria según año y especies en RSM-DC Años 2022- 2026

Especie	Años				
	2022	2023	2024	2025	2026
P. Vivax	5	16	6	**3**	**1**
P. Falciparum	4	7	0	**0**	**0**
Infección mixta	0	0	0	**0**	**0**
Total	9	23	6	**3**	**1**
Índice parasitario anual	0,68	1,73	0,44	**0.22**	**0.072**
Láminas examinadas	21	38	6	**82**	**0**
Láminas positivas examinadas	21	38	6	**3**	**1**
Tasa de incidencia especie Vivax por la poblacion del Distrito Central	0,45	1,2	0,44	**0.22**	**0.072**
Tasa de incidencia especie Falciparum por la poblacion del Distrito Central	0,3	0,52	0	**0**	**0**
Tasa de incidencia asintomáticos	0	0	0	**0**	**0**
Tasa de incidencia sintomáticos	100	100	100	**100**	**100**
Índice de certeza del Diagnóstico clínico	100%	100%	100%	**100%**	**100%**
Índice de mosquitero activos	0	0	0	**0**	**0**
Número de casas rociadas . (Los casos Importados , casas no roseadas)	9	23	0	**3**	**1**

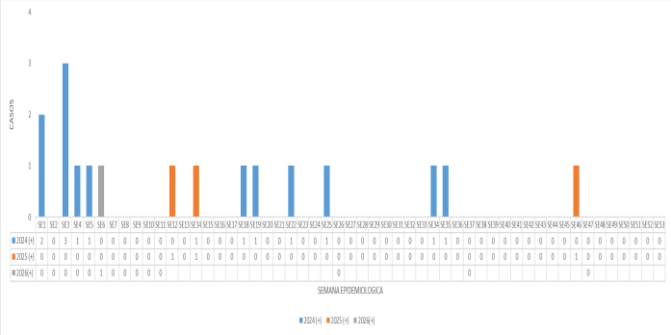
Fuente: Fichas de notificación malaria UVS-RSM 2021-2026

Vigilancia del índice de positividad % según casos de malaria en el Distrito Central infectados en otras zonas de Honduras SE11 Año 2026

Tipo de vigilancia	*Muestras*		*Sexo*	
	Gota Gruesa	*Gota Gruesa positivas confirmadas*	*Hombre*	*Mujer*
Pasiva	***1***	***1***	***1***	***0***
Activa	***0***	***0***	***0***	***0***
Proactiva	***0***	***0***	***0***	***0***
Total	***1***	***1***	***1***	***0***

Fuente: Fichas de notificación malaria UVS-RSM 2026

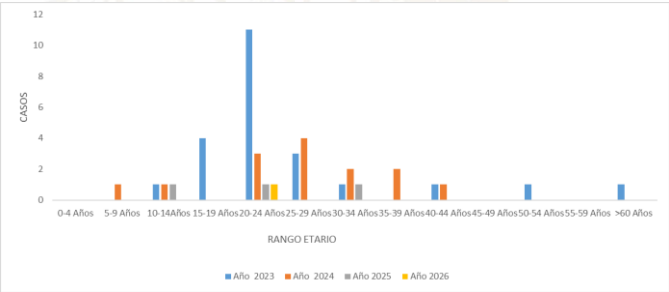
Semanas epidemiológicas según entidad de casos detectados de malaria en RSM-DC SE11/Año 2024-2026



Fuente: Fichas de notificación malaria UVS-RSM 2024-2026

A la fecha se notifica un caso de malaria en el Distrito Central, con una disminución del 60% en comparación a los casos notificados el año 2025; Para el año 2025 el 100% los casos fueron para Plasmodium Vivax (3/3).

Infectados por Malaria según rango etario RSMDC SE11-Año 2024-2026

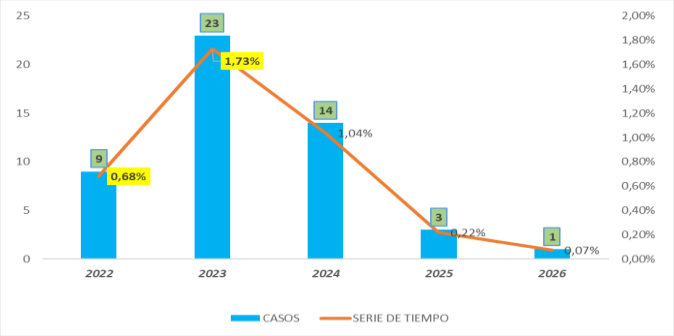


Fuente: Fichas de notificación malaria UVS-RSM 2024-2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICADE HONDURAS

SECRETARIA DE SALUD
REGIÓN SANITARIA
METROPOLITANA DEL DC

Serie de tiempos de la tasa de morbilidad de Malaria de los casos del Distrito Central infectados en otras zonas de Honduras Años SE11 Años 2022-2026



Fuente: Fichas de notificación malaria UVS-RSM 2022-2026

En esta serie de tiempo se muestra que, tras un año 2021 sin casos notificados, en 2022 se registraron nueve casos. Este patrón se intensificó en 2023 con 23 casos (n=23), reflejando un aumento del 61%. Durante el 2024, la notificación de 14 casos (con una disminución de 39% respecto a 2023) sugiere un impacto favorable de las intervenciones de vigilancia epidemiológica, búsqueda activa, diagnóstico oportuno y control vectorial focalizado. Hasta la SE 53 de 2025 se han reportado tres casos, lo que representa una reducción del 79%, indicando una tendencia sostenida hacia el control del riesgo de transmisión.

Para 2026, hasta la Semana Epidemiológica 11, se registra un caso, importado, lo cual no debe interpretarse como una reducción real de la transmisión, sino como un comportamiento esperado por el corto periodo de observación al inicio del año epidemiológico.

Clasificación de los casos de Malaria RSMDC, SE11, Año 2022-2026.

Casos	2022		2023		2024		2025		2026	
	casos	%	casos	%	casos	%	casos	%	casos	%
Aloctonos	7	77	19	82	2	14	2	67	0	0
Autóctonos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importados	2	23	4	18	12	86	0	0	1	0.07
Introducidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recaídas	0	0	0	0	0	0	1	33	0	0
Focos activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	9	100	23	100	14	100	3	100	0	0

Fuente: Fichas de notificación malaria UVS-RSM 2022-2026

Para el 2022 los casos son aloctonos locales provenientes de la Mosquitia departamento de Gracias a Dios siendo seis (6) con el 66%, un caso (1) con un 13% del departamento de Choluteca y dos (2) casos importados procedentes del continente africano pais Uganda y de Colombia America del Sur con un 22 %.

En el año 2023 de los (n=23) casos notificados hasta la **SE 52**, ***son Alóctonos locales con un 82%*** (procedentes del departamento de Gracias a Dios con 5 casos (n=5/23), Olancho con un caso (n=1/23), 6 casos para el Paraíso (n=6/23) , un caso para Choluteca (n=1/23), un caso (n=1/23) para Comayagua , y cuatro casos para Colon (n=4/23) , de los casos ***Importados el restante 18%***, con tres casos importados proveniente de Venezuela (n=3/23) y el restante caso proveniente del país Sudan continente africano (n=1/23).

En el año 2024 de los (n=14) casos notificados hasta la **SE 52**, alóctonos locales con un 14% (Procedente del departamento de Gracias a Dios con un caso y El Paraíso un caso), de los importados el 86%, provenientes de Sur América (Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile).

Hasta la SE 53 del 2025 notificaron tres casos de malaria en el Municipio del Distrito Central(Procedentes de: Gracias a Dios 67%(2/3), Choluteca 33%(1/3)).

Hasta la SE11, 2026 se ha captado un caso de malaria en el Municipio del Distrito Central.

CHAGAS SE #11

SITUACION EPIDEMIOLOGICA CHAGAS SE11 AÑO 2026: Hasta la **SE10** del año 2026, se han reportado un acumulado de 12 casos para Chagas en fase crónica, para la misma SE del año 2025 se reportó un acumulado de 8 casos para la enfermedad de Chagas, en el Distrito Central.

A la Semana Epidemiológica 11 no se registran ingresos hospitalarios. Asimismo, durante la SE 11 del año 2026 no se han notificado defunciones por enfermedad de Chagas, en comparación a la misma SE del año 2025.

Tasa de Morbilidad Chagas SE11 RSMDC, Año 2026

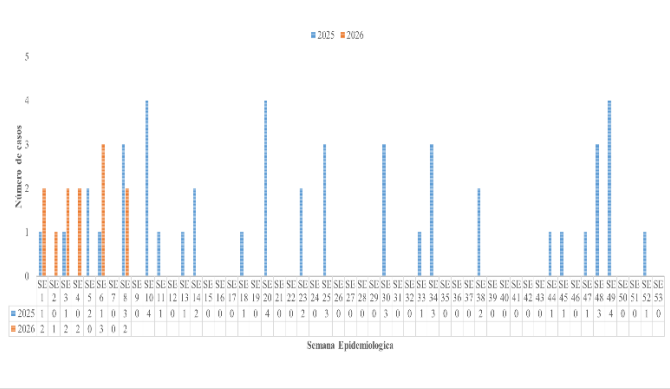
TASA DE LA REGION 2025	**3.38%**
TASA DE LA REGION 2026	**0.87%**
AUMENTO	**0%**
DISMINUCION	**78%**

Por 100mil habitantes
Pob 2026 = 1.372.705 habitantes
Fuente: Fichas de notificación Chagas UVS-RSM 2025-2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICADE HONDURAS

SECRETARIA DE SALUD
REGIÓN SANITARIA
METROPOLITANA DEL DC

Semanas Epidemiológicas según entidad de casos detectados de Chagas en RSM-DC SE11/Año 2025-2026



Fuente: Fichas de notificación Chagas UVS-RSM 2025-2026

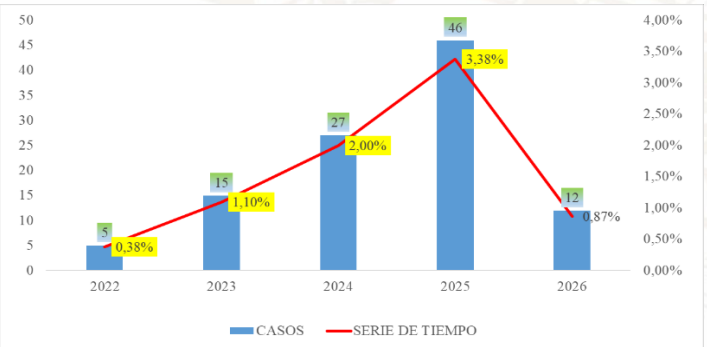
Cabe destacar que actualmente se realiza el tamizaje de Chagas en mujeres embarazadas, el cual se ha extendido en cierta proporción a la población general, lo que ha permitido la captación oportuna de casos positivos. Hasta la Semana Epidemiológica 11 del 2026 se ha notificado un caso de Chagas en gestante en el Distrito Central, en contraste con el año 2025, en el que hasta la SE 53 se registraron 16 casos, correspondientes al 35% (16/46) del total de casos reportados.

Vigilancia del índice de Positividad % según casos Chagas SE11 Año 2026

Tipo de vigilancia	*Muestras*		*Sexo(+)*	
	POSITIVAS	*NEGATIVAS*	*HOMBRE (+)*	*MUJER (+)*
Aguda	**0**	**0**	**0**	**0**
Crónica	**12**	**0**	**6**	**6**
Total	**12**	**0**	**6**	**6**

Fuente: Fichas de notificación Chagas UVS-RSM Año 2026

Serie de tiempos de la tasa de morbilidad de Chagas RSMDC Años 2022-2026



Fuente: Fichas de notificación Chagas UVS-RSM 2022-2026

En esta serie de tiempo se muestra un incremento sostenido de los casos de enfermedad de Chagas entre 2022 y 2025. En 2022 se notificaron 5 casos, lo que representó una tasa aproximada de 0,38%. Para 2023 los casos aumentaron a 15 (1,10%), y en 2024 se observó un nuevo incremento hasta 27 casos (2,00%), lo que evidencia una tendencia ascendente continua tanto en número de casos como en proporción.

En 2025 se alcanza el pico más alto del periodo, con 46 casos notificados y una tasa de 3,38%, lo que indica tomando en cuenta que hasta la SE15 del 2025, no se tenían reactivos, un incremento significativo en la capacidad de detección del sistema de vigilancia, asociado a la ampliación del tamizaje y a una mayor búsqueda activa de casos, como ha ocurrido con el tamizaje en embarazadas y población general.

Para 2026, hasta la Semana Epidemiológica 11, se registran 12 casos en el Distrito Central.

LEISHMANIASIS SE #11

SITUACION EPIDEMIOLOGICA LEISHMANIASIS SE11 AÑO 2026

Hasta la Semana Epidemiológica **No.11** Año 2026, no se reporta casos para leishmaniasis en el Distrito Central. En comparación con los dos casos reportados a la misma semana en el año 2025.

No se reporta en la Semana epidemiológica 11 Ingreso Hospitalario u alguna defunción por Leishmaniasis en el Distrito Central.

Tasa de Morbilidad Leishmaniasis SE11 RSMDC, Año 2026

TASA DE LA REGION 2025	**0.59%**
TASA DE LA REGION 2026	**0%**
AUMENTO	**0%**
DISMINUCION	**100%**

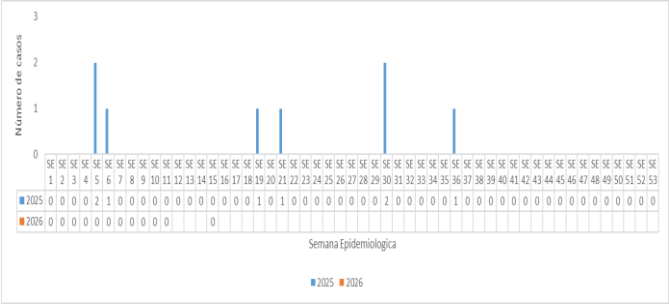
Por 100mil habitantes
Pob 2026 = 1.372.705 habitantes
Fuente: Fichas de notificación Leishmaniasis UVS-RSM 2025-2026

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO ENFERMEDADES DESATENDIDAS
SE11, Año 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SALUD
REGIÓN SANITARIA
METROPOLITANA DEL DC

Semanas Epidemiológicas según entidad de casos detectados de Leishmaniasis en RSM-DC SE11/Año 2025-2026



Fuente: Fichas de notificación Leishmaniasis UVS-RSM 2025-2026

Durante el año 2025, los casos de leishmaniasis presentaron un patrón intermitente a lo largo de las semanas epidemiológicas. Se observa que los casos se concentraron principalmente en las semanas epidemiológicas: 3, 6, 19, 22, 28 y 34 en total, el año 2025 presentó un número reducido de casos distribuidos de manera esporádica.

Para el año 2026, hasta la semana 11, no se han reportado casos de leishmaniasis.

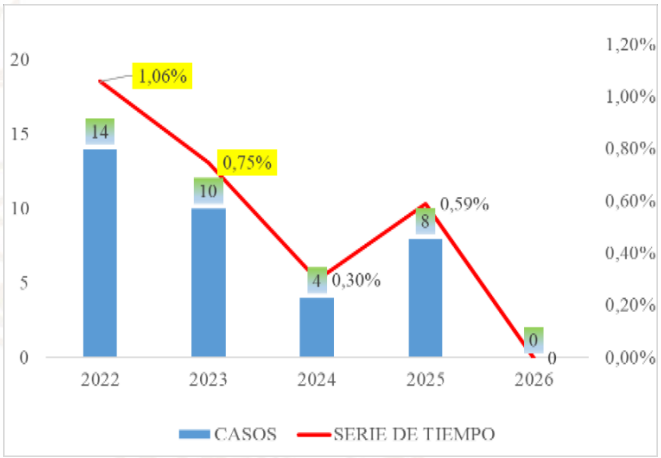
Toma de muestra según casos Leishmaniasis SE11 Año 2026

Tipo de Vigilancia	*Muestras*		*Sexo*	
	POSITIVAS	*NEGATIVAS*	*HOMBRE (+)*	*MUJER (+)*
Mucocutánea	**0**	**0**	**0**	**0**
Cutanea	**0**	**0**	**0**	**0**
Visceral	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Fuente: Fichas de notificación Leishmaniasis UVS-RSM Año 2026

Hasta la **SE11** del año 2026 no se notifican casos para leishmaniasis con resultados positivos (**Hay que recalcar que los casos reportados durante el 2025 el 100% tuvieron desplazamientos meses anteriores a lugares endémicos donde se encuentra el Vector**).

Serie de tiempos de la tasa de morbilidad de Leishmaniasis RSMDC-SE11 Años 2022-2026



Fuente: Fichas de notificación Leishmaniasis UVS-RSM 2022-2026

En esta serie de tiempo se muestra un descenso sostenido de los casos de leishmaniasis entre 2022 y 2025. En 2022 se notificaron 14 casos, lo que representó una tasa aproximada de 1,06 %. Para 2023 los casos disminuyeron a 10 (0.75%), y en 2024 se observó un nuevo descenso hasta 4 casos (0.30%), lo que evidencia una tendencia descendente continua tanto en número de casos como en proporción.

En 2025 se presenta un ascenso, con 8 casos notificados y una tasa de 0.59%, lo que indica un incremento significativo en la capacidad de detección del sistema de vigilancia.

Para 2026, hasta la Semana Epidemiológica 11, no se registran casos, lo cual no debe interpretarse como una reducción real de casos, sino como un comportamiento esperado por el corto periodo de observación al inicio del año epidemiológico

LEPTOSPIROSIS SE #11

SITUACION EPIDEMIOLOGICA LEPTOSPIROSIS SE 11 AÑO 2026. Hasta la Semana Epidemiológica No.11 Año 2026, No se reportan casos para Leptospirosis en el Distrito Central. En comparación con los casos acumulados reportados a la misma semana en el año 2025 (n=0). **No se reporta defunción por Leptospirosis en el Distrito Central.**

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO ENFERMEDADES DESATENDIDAS
SE11, Año 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SALUD
REGIÓN SANITARIA
METROPOLITANA DEL DC

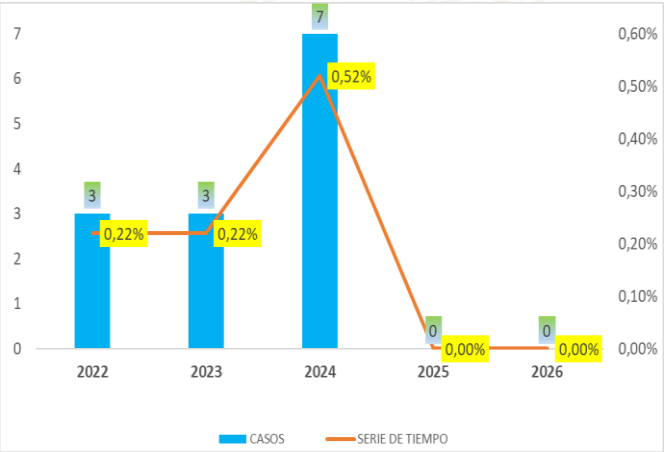
Tasa de Morbilidad Leptospirosis SE11 RSMDC, Año 2026

TASA DE LA REGION 2025	**0 %**
TASA DE LA REGION 2026	**0%**
AUMENTO	**0%**
DISMINUCION	**0%**

Por 100mil habitantes
Pob 2026 = 1.372.705 habitantes
Fuente: Fichas de notificación Leptospirosis UVS-RSM 2025-2026

Para la SE11 del 2026 no se reportó caso positivo para Leishmaniasis.

Serie de tiempos de la Tasa de Morbilidad de Leptospirosis RSMDC- SE11 Años 2022-2026



Fuente: Fichas de notificación Leptospirosis UVS-RSM 2022-2026

En esta serie de tiempo se muestra un descenso sostenido de los casos de leptospirosis a partir del 2024. En 2022 se notificaron 3 casos, lo que representó una tasa aproximada de 0.22 %. Para 2023 los casos se mantuvieron en 3 casos (0.22%), y en 2024 se observó un incremento con 7 casos (0.52%), lo que indica un incremento significativo en la capacidad de detección del sistema de vigilancia.

En 2025 se presenta un descenso sostenido, sin notificacion de casos.

Para 2026, hasta la Semana Epidemiológica 11, no se registran casos, lo cual no debe interpretarse como una reducción real de casos, sino como un comportamiento esperado por el corto periodo de observación al inicio del año epidemiológico.

BRUCELOSIS SE #11

SITUACION EPIDEMIOLOGICA BRUCELOSIS SE11 AÑO 2026 Hasta la Semana Epidemiológica No.11 – Año 2026, no se reportan casos de Brucelosis, en comparación con los casos reportados a la misma semana en el año 2025 (n=0).

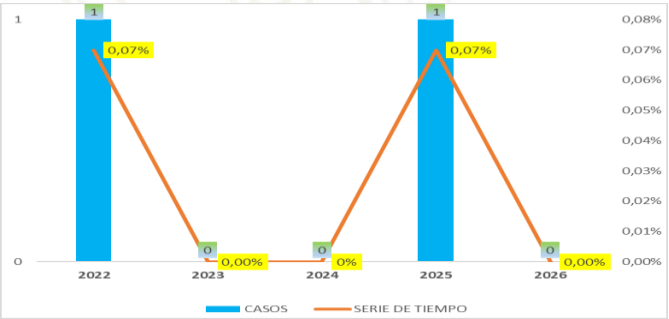
No se reporta hasta la Semana epidemiológica 11, Ingresos Hospitalarios ni defunciones por Brucelosis en el Distrito Central.

Tasa de Morbilidad Brucelosis SE11 RSMDC, Año 2026

TASA DE LA REGION 2025	**0,07%**
TASA DE LA REGION 2026	**0,00%**
AUMENTO	**0%**
DISMINUCION	**0%**

Por 100mil habitantes
Pob 2026 = 1.372.705 habitantes
Fuente: Fichas de notificación Brucelosis UVS-RSM 2025-2026

Serie de tiempos de la Tasa de Morbilidad de Brucelosis RSMDC- SE11 Años 2022-2026



Fuente: Fichas de notificación Brucelosis UVS-RSM 2022-2026

En esta seria de tiempos, se demuestra hasta el año 2022 los casos detectados y notificados de Brucelosis en comparación al año 2021 han aumentado en un 100 por ciento hasta la SE52.

Para el año 2023 no hay casos reportados para Brucelosis, así mismo para el año 2024 no se han reportado casos para Brucelosis.

Para la SE41 del 2025 se observa un ascenso con un caso notificado, procedente de Tamara.

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO ENFERMEDADES DESATENDIDAS
SE11, Año 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SALUD REGIÓN SANITARIA METROPOLITANA DEL DC

Para 2026, hasta la Semana Epidemiológica 11, no se registran casos, lo cual no debe interpretarse como una reducción real de casos, sino como un comportamiento esperado por el corto periodo de observación al inicio del año epidemiológico.

GUSANO BARRENADOR DEL GANADO SE #11

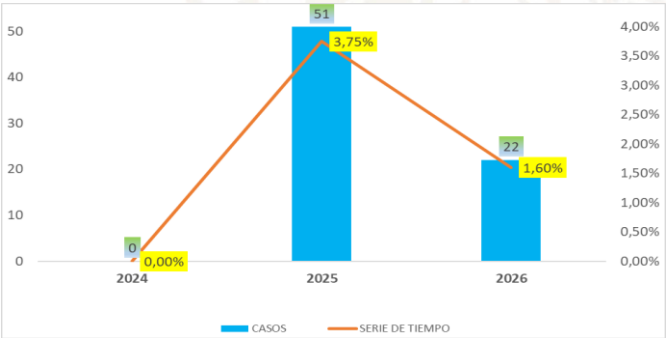
Situación Epidemiológica Región Sanitaria #19, Honduras SE11/ Año 2026: Hasta la Semana Epidemiológica No.11 Año 2026, se han confirmado 22 casos de miasis a causa de GBG. Hasta la Semana Epidemiológica 53 Año 2025, se notificaron un total de 69 sospechas de Miasis en GBG en humanos de los cuales se confirmaron 51 casos, 11 descartados y 7 pendientes de resultado de SENASA(Hasta la fecha no se recibió notificación de resultado).

Tasa de Morbilidad de GBH RSMDC, SE11 Año 2025-2026

TASA DE LA REGION 2025	3.75
TASA DE LA REGION 2026	1.6
TASA DE MORTALIDAD	0.15
DISMINUCIÓN	57%
AUMENTO	0

Por 100mil habitantes
Pob 2026 = 1.372.705 habitantes
Fuente: Fichas de notificación GBH UVS-RSM 2026

Serie de tiempos, tasa de morbilidad de GBH casos confirmados del MDC confirmados año 2024-2026



Fuente: Fichas Epidemiológicas Miasis UVS-RSM 2024-2026

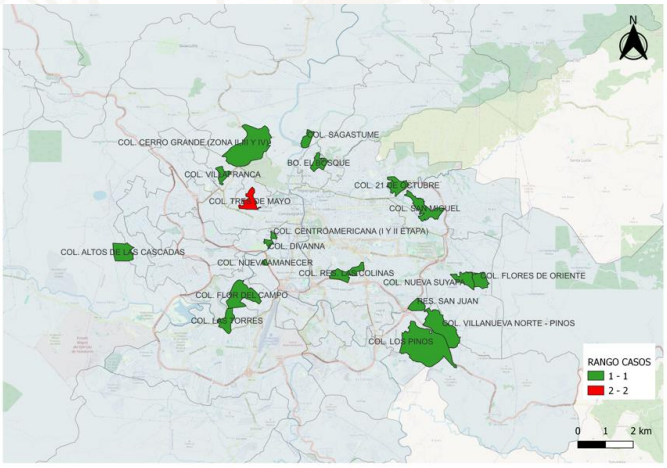
En esta serie de tiempo se muestra un ascenso de los casos de miasis a causa de GBG a partir de la SE11 2025. Para el 2024 no habia presencia de la enfermedad en el pais, es hasta la SE11 del 2025 que se presenta los primeros casos, finalizando el 2025 con 51(3.75%) casos confirmados por SENASA, en el Distrito Central, lo que indica un incremento sostenido de los casos durante el año.

Para 2026, hasta la Semana Epidemiológica 10, se ha recibido notificaciòn de 19 sospechas de miasis por GBG de las cuales se han confirmado 18 casos y se tiene pendiente recibir resultado de un caso sospechosos por parte de SENASA.

En esta serie de tiempo podemos observar 22 casos en las primeras 11 semanas del año, lo que indica persistencia de la transmisión luego de su establecimiento en 2025. La ocurrencia temprana confirma que el riesgo continúa activo.

Hasta la fecha se ha notificado dos defunciones por miasis en el Distrito Central durante el 2026, uno confirmado por GBF y el otro pendiente de resultado.

Casos confirmados de Miasis GBG en humanos, según colonia, MDC SE 1-11 año 2026.



Fuente: Fichas Epidemiológicas Miasis UVS-RSM 2026

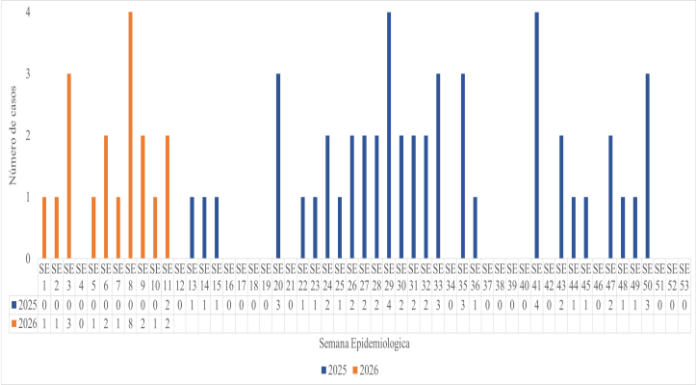
Hasta la semana epidemiológicas 11-2026, se notificaron 21 casos de miasis humana en distintas colonias del municipio del Distrito Central, evidenciando una distribución geográfica dispersa con presencia de casos aislados en varios sectores. Este patrón sugiere un comportamiento esporádico del evento, sin observarse hasta el momento una concentración marcada de casos que indique un conglomerado epidemiológico. No

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SALUD
REGIÓN SANITARIA
METROPOLITANA DEL DC

obstante, la identificación de casos en diferentes zonas del municipio refleja la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica activa, fortalecer la investigación de cada caso y promover medidas de prevención y control orientadas a reducir factores de riesgo asociados a la presencia de moscas y al manejo adecuado de heridas.

Semanas epidemiológicas según entidad de casos detectados de GBG en RSM-DC SE11/Año 2024-2026

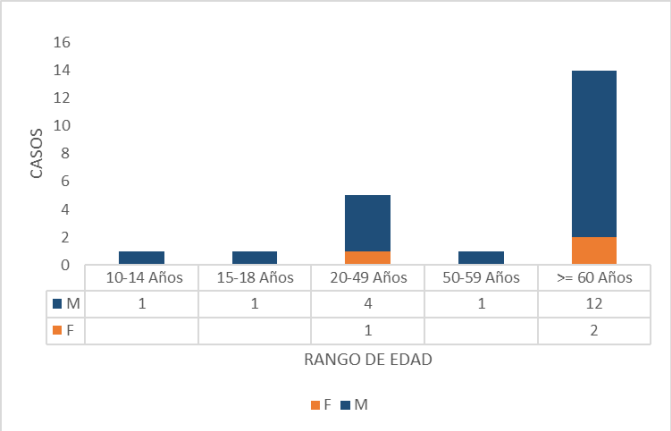


Fuente: : Fichas Epidemiológicas Miasis UVS-RSM 2026

Al inicio del año epidemiológico 2026, se observa la presencia de 21 casos confirmados de miasis por GBG, evidenciando una mayor notificación y un comportamiento irregular y presencia de picos en varias semanas epidemiológicas, es importante destacar que este evento fue reportado por primera vez en el Municipio del Distrito Central durante la SE11, 2025. Dado que la enfermedad era inexistente antes de esta SE en este municipio.

Para el 2025 se registraron 51 casos confirmados por SENASA. Este comportamiento resalta la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica activa, la notificación oportuna y el seguimiento de los casos para orientar acciones de prevención y control.

Distribución de casos confirmados por sexo y rango de edad RSMDC SE11-2026



Fuente: Fichas Epidemiológicas Miasis UVS-RSM 2026

De los casos confirmados de Miasis GBG en humanos el sexo más afectado es el masculino con un 86% (19/22) entre rango etario:

≥60 años: 14 casos (64%), 20 a 49: 5 casos(23%), 10 a 18 años: 2 casos (10%).

La distribución de casos por edad y sexo evidencia concentración en población adulta, con predominio en el sexo masculino. Los casos se presentan principalmente en los grupos de 20-49 años y ≥60 años, siendo este último el más afectado. Este patrón sugiere mayor exposición en adultos, posiblemente relacionada con factores ocupacionales o ambientales, así como mayor vulnerabilidad en adultos mayores, lo que orienta a fortalecer acciones de prevención, vigilancia y detección temprana en estos grupos prioritarios.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UVS RSMDC:

Notificación inmediata de casos confirmados, mediante elaboración de informe epidemiológico.

Coordinación de investigación con nivel local para búsqueda de nexo.

Coordinación con epidemiologia de Hospital Escuela/IHSS y jefes de CIS para seguimiento de casos.